Diskussion 843

Datum: 1939-05-02
Kammare: Första kammaren
Antal yttranden: 2
Källa: Tal om Kvinnor: Annotated Corpus (doi:10.5281/zenodo.18211787), byggd på The Swedish Parliament Corpus (Yrjänäinen m.fl. 2024).

Markerade ord: ¹ kvinna-ord, ² släktskaps- och tilltalsord, ³ yrkestitlar.

1. Nils Herlitz (Högerpartiet, man)

Herr talman! I detta utlåtande är det fråga om startandet av en ny form av social hjälpverksamhet, nämligen utdelning av s. k. skyddsläkemedel. Då vi mottogo den kungl. propositionen i ämnet, föreföll det mig påfallande, att propositionen icke innehöll något närmare angivande av de grunder, enligt vilka dessa läkemedel skuile fördelas, och icke heller något närmare om det förfarande, som skulle tillämpas. Detta föreföll mig stå i

Ang. skyddsläkemedel åt vissa **kvinnor¹** och barn. (Forts. ganska bjärt motsättning till den omsorg, som man eljest brukar nedlägga på utformandet av regler för samhällets understödsverksamhet, i synnerhet på det sociala området. Utskottet har emellertid delat Kungl. Maj:ts mening i detta hänseende och funnit, att inga närmare grunder för detta anslags disponerande för närvarande kunna fastställas.

Jag har icke velat underlåta att fästa kammarens uppmärksamhet på detta förhållande. Det är ju så, att det icke ens är närmare preciserat, vilka sorter av läkemedel, som enligt det riksdagsbeslut, vilket nu kommer att fattas, skola kunna utdelas gratis till medborgare i allmänhet. Jag står för min del frågande, huruvida det är meningen, att exempelvis bröstmedicin åt mina barn skall bekostas av dessa allmänna medel? Nu kan möjligen någon invända, att det tillsvidare är fråga om ett jämförelsevis litet anslag; det gäller ett förslagsanslag av 150,000 kronor. Jag står emellertid rätt tveksam även inför beräkningen av anslagets storlek. Förhållandet är det, att enligt de uträkningar, som ha gjorts av befolkningskommissionen, skulle det årliga behovet av sådana läkemedel uppgå till 800,000 kronor. Kungl. Maj:t hyser emellertid den förväntan, att man under de första åren kan räkna med ett betydligt mindre belopp, och anslaget har därför tagits upp såsom ett — jag betonar det — förslagsanslag av 150,000 kronor.

Jag har försökt att underhand göra klart för mig, vad det kan vara för omständighet, som föranleder denna optimistiska beräkning, och man har då påpekat, att innan de centraler för förebyggande **mödraoch²** barnavård, som äro tänkta såsom utdelare av ifrågavarande läkemedel, komma i gång, skall det egentligen icke bli någon fart på denna verksamhet. Jag står frågande inför denna beräkning, ty om man ser på propositionen är det ju meningen, att sådana läkemedel, innan dessa anstalter komma i gång, skola kunna rekvireras av vederbörande distriktssköterskor och barnmorskor. Det förefaller sålunda icke vara någon svårighet för dem, som önska läkemedel, att vända sig till dessa befattningshavare och få den

hjälp som avses.

Jag kan sålunda icke finna annat än att denna Kungl. Maj:ts förväntan, att det icke skall behövas mer än 150,000 kronor, är synnerligen löst grundad, och jag sätter mycket starkt i fråga, huruvida vi icke med avseende på detta anslag ha att vänta sådana väldiga överskridanden, som vi i år fått bevittna i en annan social understödsform, som startades för något år sedan; jag syftar på **mödrahjälpen²**.

Jag har i sakens nuvarande läge och inför ett enhälligt utskott icke något yrkande att framställa. Jag skulle emellertid gärna vilja rikta en fråga till dem det vederbör, huruvida de ha några starkare grunder än dem, som jag nu har antytt, för sin förmodan, att medelsbehovet skall inskränka sig till dessa 150,000 kronor eller något däromkring.

2. Ivan Pauli (Socialdemokraterna, man)

Herr talman! Då den föregående ärade talaren inte har framställt något yrkande, är det kanske inte nödvändigt att från statsutskottets sida något utförligare säges om denna sak. Men det föreföll som om han 1 vissa avseenden vore något dåligt underrättad, och därför har jag tillåtit mig att begära ordet för ett kort anförande. Jag skulle kanske i förbigående påpeka för honom, att statsutskottet icke är enhälligt i denna punkt. Det finnes nämligen två reservanter, ehuru båda befinna sig inom andra kammaren.

Den proposition, som det här gäller, var ursprungligen planerad att få en mera omfattande beskaffenhet och avsåg ett förslag från befolkningskommissionen om icke blott sådana läkemedel, som det här är fråga — skyddsläkemedel — utan även vissa näringsmedel. Man har tagit sikte på sådana fall, då särskilt **mödrar²** och nyfödda barn, men även barn i de första åren och i

Ang. skyddsläkemedel åt vissa **kvinnor¹** och barn. (Forts.) den tidigaste skolåldern befinna sig under dåliga näringsförhållanden och deras hälsa skulle kräva en bättre kost, inriktad på alldeles särskilda behov; speciellt har man velat förhindra uppkomsten av vissa välbekanta barnsjukdomar, exempelvis rachitis eller engelska sjukan. Emellertid har, som vi se, vederbörande departementschef avstått från att i år framlägga det vittutseende förslag, som skulle avse de ifrågavarande näringsmedlen, och inskränkt sig till det mindre omfattande förslaget om skyddsläkemedel.

I det sammanhang, som jag nu har hänvisat till, ligger i själva verket svaret på en fråga, som herr Herlitz framställde, nämligen vad det är för slags läkemedel det gäller. Herr Herlitz undrade bland annat, om han för sina barn skulle kunna påräkna t. ex. gratis bröstmedicin på statens bekostnad. Jag betvivlar det. Det är nämligen inte fråga om medicin i vanlig mening, om läkemedel för vissa akuta eller kroniska sjukdomar av annan art än dem, som jag nyss antydde. Det är tydligen endast fråga om sådana läkemedel, som skulle kunna användas för att avhjälpa följderna av dåliga näringsförhållanden, för att icke säga direkt undernäring. Man kan naturligtvis säga, att man i det avseendet aldrig kommer så värst långt med blott och

bart läkemedel, och att det som framför allt hjälper är födoämnen. Men vi ha inte nu den frågam uppe, och det framgår av vad medicinska auktoriteter sagt, att man särskilt i fråga om spädbarn men även äldre barn kan åstadkomma åtskilligt med hjälp av vissa skyddsläkemedel. Ett gammalt känt sådant är ju fiskleverolja och liknande preparat. Jag vill inte här uppträda som någon apostel speciellt för fiskleverolja, och jag tror inte att den har någon allena saliggörande verkan. Jag har hört talas om att en professor i Uppsala har gjort experiment med fiskleverolja på någon sorts små djur, och det har visat sig, att när man är alltför frikostig med detta preparat, kan man råka förkalka dessa små djurs hjärtan. Man är ju van att höra talas om förkalkning hos äldre personer, men det är egendomligt att tänka sig att små barn kunna drabbas av något liknande. En viss risk härför synes emellertid framgå av de nämnda experimenten.

Jag har velat erinra härom endast för att framhålla vad vi från utskottets sida ha understrukit, nämligen att ordinerandet av sådana skyddsläkemedel måste ske med den största omsorg. När vi ha gått med på det i den kungl. propositionen framlagda förslaget, att i de fall, då sådana centraler som skulle uppbyggas i samband med **mödraoch²** barnavården, ännu inte ha kommit till stånd, skyddsläkemedel skulle kunna utanordnas av distriktssköterskor och barnmorskor, så ha vi starkt betonat, att det skall ske under betryggande medverkan och kontroll av vederbörande tjänsteläkare. Om vi härmed jämföra ordalagen i propositionen, finna vi, att utskottet har skärpt dessa ordalag och alltså ytterligare velat understryka vikten av iakttagande av försiktighet. Emellertid bör det också vara skäl att komma i håg, att ordinerandet av de läkemedel, som det här gäller, på det hela taget är en vida mindre riskabel historia än ordinerandet av annan medicin, till och med av de bröstdroppar, som herr Herlitz talade om.

Jag tror alltså inte, att det ur medicinsk synpunkt finnes någonting att anmärka mot det av utskottet tillstyrkta förslaget, och herr Herlitz får nog erkänna, att han inte hade tillräckligt studerat betänkandet, innan han förklarade, att det inte var nämnt, vilka sorter av läkemedel som skulle utdelas. Vad hans motion egentligen gick ut på var, att utskottet och riksdagen skulle uppställa närmare preciserade grunder för utdelandet av sådana här läkemedel. Utskottet har verkligen inte ansett sig kompetent att författa ett dylikt reglemente, 1 synnerhet som vi måste konstatera, att motionären själv gjort saken ganska lätt för sig genom att blott uttala ett platoniskt önskemål i den vä-

Ang. skyddsläkemedel åt vissa **kvinnor¹** och barn. (Forts.) gen utan att ens antyda, efter vilka riktlinjer han eventuellt önskade, att ett sådant reglemente skulle gå. Vi ha delat den uppfattningen, som är uttalad 1 propositionen, att man här gör ett försök och att man vill bygga på en vidare erfarenhet, innan man går in på en närmare reglering. Med de allmänna riktlinjer, som redan äro givna, och med den ytterligare varning, som givits i utskottsutlåtandet, att man i möjligaste mån skall förebygga alla missbruk av denna statens frikostighet, tror jag att vi tills vidare kunna anse, att vi äro tryggade i detta avseende.

Sedan uppställde talaren också frågan om hur mycket detta kommer att kosta. Naturligtvis kunna vi från utskottets sida inte ge några bestämda garantier för att kostnaderna komma att begränsa sig till precis den summa, som här är nämnd som ett förslagsanslag. Det är möjligt, att den kommer att överskridas, och det har man ju ingalunda stuckit under stol med i propositionen. Huruvida de beräkningar, som äro gjorda på sid. 22 i utskottsutlåtandet och som äro citerade ur propositionen, komma att visa sig motsvara de verkliga förhållandena, kan jag inte yttra mig om, men nog förefaller det mig som om de snarast vore tilltagna i överkant och som om den antydda miljonen skulle vara en ganska duktigt tilltagen summa. Svårigheten att här göra några beräkningar ökas givetvis av den omständigheten, som jag berörde i början av anförandet, nämligen att man här har brutit ut en detalj av ett omfattande förslag, i vilket skyddsläkemedel endast skulle ha ingått såsom en mindre post jämte den större och viktigare posten med tillhandahållandet av lämpliga födoämnen åt **mödrar²** och barn. Med den utformning, som såväl propositionen som utskottsutlåtandet ha fått, tror jag emellertid, att det inte finnes någon anledning för kammaren att tveka att bifalla utskottets hemställan, vilken ju, vad denna kammare beträffar, är enhällig.

Det ändamål, som man med detta förslag avser att fylla, är i allra högsta grad lovvärt, och vad som här kan åstadkommas bör utgöra ett mycket behövligt bidrag till förekommande av den ännu alltjämt sorgligt utbredda sjukligheten bland spädbarn och även inom de något högre barnaåldrarna i vårt land.

Jag ber med dessa ord, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.